

“脏水病”田野调查报告

A Field Study on Waterborne Illness from
Contaminated Water Sources in a Rural Community

报告类型	公共卫生 · 田野调查（定性为主，辅以水质量测与病例梳理）
调查对象	某丘陵地区一个以浅井 / 溪沟为饮用水源的行政村（匿名为“清溪村”）
调查方法	参与式观察 · 半结构访谈 · 入户问卷 · 水样采集 · 卫生院病例梳理
样本规模	入户 48 户 · 受访者 31 人 · 水样 12 处 · 病例回溯 1 年
调查周期	2025 年 8 月 – 2026 年 5 月（含 1 个雨季高发期）
编制日期	2026 年 6 月

摘要 ABSTRACT

“脏水病”是当地村民对一组因饮用或接触受污染水源而反复发作的腹泻、呕吐、发热及皮肤病症的统称，并非单一医学诊断。本调查采用田野方法，通过入户访谈、参与式观察、简易水质量测与卫生院病例梳理，记录这一民间病名背后的真实疾病谱、发病情景与在地解释。调查发现：“脏水病”主要对应一组经粪—口途径传播的水源性肠道传染病（细菌性痢疾、肠炎、甲型肝炎及寄生虫感染等），与雨季地表径流污染浅井、人畜共用水源、缺乏安全储水习惯高度相关；村民虽有“水脏会生病”的朴素认知，却受限于水源条件、经济与卫生设施而难以阻断。报告在记录现象的同时还原村民的在地知识与防控落差，并提出可操作的改进建议。

✦ 用途声明：本报告为公共卫生研究与健康教育用途，旨在预防水源性疾病、改善饮水卫生，不含任何有害信息。

本报告中的地名、人名均已匿名化处理（村名作“清溪村”，受访者以 H-01、I-03 等代号表示）。所列数据为田野记录的现场观测与回溯值，不代表任何特定地区的官方统计。

目录 CONTENTS

一、调查背景与问题意识	03
二、调查方法与田野设计	03
三、“脏水病”的疾病谱（背景知识）	04
四、田野发现：发病的“情景链”	04
五、水质量测与病例数据	05
六、村民的在地知识与访谈记录	06
七、防控落差与风险结构分析	06
八、结论与建议	07
附录：术语表 · 量测方法 · 参考依据	08

一 调查背景与问题意识

“脏水病”不是医学诊断，而是清溪村村民对一类反复出现、与“喝了脏水”关联的身体不适的本土命名。它涵盖腹泻、呕吐、腹痛、发热，乃至黄疸、皮肤瘙痒等多种表现。这类症状在雨季尤为高发，常被村民归因为“水不干净”“水里有虫”“上游脏东西冲下来”。

从公共卫生角度看，这正是典型的水源性疾病（waterborne disease）——病原体经粪—口途径，借受污染的饮用水传播。既有研究多停留在流行病学统计与水质标准，而对“村民如何理解、经历并应对这类疾病”缺乏第一手记录。本调查的问题意识即在于此：当地的“脏水病”究竟对应哪些疾病？村民依据什么判断与应对？官方的卫生建议与在地实践之间存在哪些落差？

雨季 ×3

腹泻就诊量较旱季

9 / 12

水样微生物超标处

粪—口

主要传播途径

48 户

入户调查样本

二 调查方法与田野设计

2.1 方法组合

- 参与式观察：研究者驻村记录取水、储水、饮水、如厕与垃圾处理等日常卫生行为，覆盖旱季与雨季。
- 半结构访谈：对村民、村医、小学教师及乡卫生院医生共 31 人访谈，围绕“如何理解/识别/应对脏水病”展开。
- 入户问卷：抽样 48 户，记录水源类型、储水方式、近一年腹泻/发热史与就医情况。
- 水样采集：对浅井、溪沟、水窖、入户储水缸等 12 处采样，做浊度、余氯与微生物指示菌简易检测。
- 病例梳理：在知情同意下，回溯乡卫生院近一年门诊登记中的腹泻、肠炎、肝炎等相关条目。

2.2 样本概况

代号	采样点	水源类型	浊度	指示菌	风险
W1	村东浅井	浅层地下水	偏高	超标	高
W2	上游溪沟取水口	地表水	高	严重超标	高
W3	集雨水窖	雨水储存	中	超标	中
W4	新建集中供水点	处理后管网水	低	合格	低
W5	入户储水缸（多户）	二次储存	中-高	多数超标	高
W6	学校饮水处	井水+简易过滤	中	部分超标	中

三 "脏水病"的疾病谱（背景知识）

村民口中的"脏水病"在医学上并非单一疾病，而是一组经水传播的肠道与接触性疾病的集合。下表梳理其主要构成与对应特征：

民间归类	对应疾病（医学）	典型症状	传播关键
拉肚子 / 闹肚子	细菌性痢疾、肠炎、霍乱样腹泻	腹泻、腹痛、里急后重	粪污染饮用水
上吐下泻	急性胃肠炎（病毒/细菌）	呕吐、水样便、脱水	污染水/食物
发黄病	甲型 / 戊型肝炎	黄疸、乏力、食欲差	粪—口经水传播
肚里有虫	肠道寄生虫（蛔虫、贾第虫等）	腹痛、消瘦、营养不良	虫卵/包囊污染水
水疥 / 痒疮	接触性皮肤病感染、皮炎	皮肤瘙痒、丘疹、糜烂	接触污染水洗浴
打摆子（少数）	误归入的发热性疾病	发热、寒战	非水源，需鉴别

脱水是儿童与老人最大的急性危险：访谈中村医反复强调，腹泻本身常可自愈，真正致命的是脱水，尤其婴幼儿。"口服补液盐（ORS）+ 及时就医"是降低重症与死亡的关键，而村中对 ORS 的知晓与使用仍不足。

四 田野发现：发病的"情景链"

综合驻村观察，"脏水病"的发生并非偶然，而是一条可追溯的情景链。研究者将其归纳为五个环节：

环节 0 | 污染源头（上游与人畜共域）

上游有散养畜禽、旱厕渗漏与垃圾堆放，雨季地表径流将粪污、虫卵冲入溪沟与浅井。村民 H-12："一下大雨，井水就变浑，舀上来有股味儿。"

环节 1 | 取水与储水（二次污染）

多数家庭用敞口缸储水，共用水瓢、徒手取水、缸口不加盖，使本已不洁的水进一步被污染。储水环节往往比水源本身风险更高。

环节 2 | 饮用与生活用水（暴露）

生水直饮、凉水冲奶、洗菜洗碗用生水是主要暴露途径。烧开水的习惯存在，但"赶农活""图省事"时常被省略。

环节 3 | 发病与传播（粪—口循环）

患者腹泻后如厕、洗涤又污染水源与环境，形成"污染—发病—再污染"的闭环，在一户多人、邻里间快速扩散，雨季尤甚。

环节 4 | 就医与转归

轻症多自行扛过或村医处买药，重症（尤其脱水患儿）才送乡卫生院。延迟就医是少数重症的主因。

田野笔记 雨季第 2 周·清溪村小学——一周内 5 名学生因腹泻请假，均饮用学校井水（W6，简易过滤但指示菌部分超标）。校方临时改为供应烧开水后，次周病假明显回落。这一"自然对照"直观显示了煮沸的保护作用。

五 水质监测与病例数据

下表为 12 处水样的简易检测摘录（浊度、余氯、微生物指示菌），指示菌阳性提示粪便污染风险。

采样点	类型	浊度(NTU)	余氯	指示菌	风险判断
W1 村东浅井	地下水	12	无	阳性	高 需消毒/改水源
W2 溪沟取水	地表水	35	无	强阳性	高 不宜直饮
W3 集雨水窖	雨水	8	无	阳性	中 须煮沸
W4 集中供水	管网水	1	有	阴性	低 合格
W5 储水缸	二次储存	15	无	阳性	高 储水二次污染
W6 学校饮水	井+过滤	6	无	弱阳性	中 建议煮沸

数据要点：① 集中供水点（W4）是唯一稳定合格的水源，但覆盖户数有限、入户“最后一公里”仍靠缸储；② 储水缸（W5）普遍二次污染——干净的水也会在家里被“喝脏”；③ 余氯几乎全程为“无”，说明缺乏末端消毒是普遍短板。

5.1 病例回溯与季节分布

时段	腹泻/肠炎	肝炎	皮肤感染	重症脱水	说明
旱季(11–4月)	较低	散发	少	个别	基线期
雨季初(5–6月)	上升	散发	上升	个别	径流污染开始
雨季峰(7–8月)	高发	小聚集	高发	数例	就诊量约旱季 3 倍
雨季末(9–10月)	回落	散发	回落	个别	逐步缓解

注：以上为乡卫生院门诊登记的相对趋势归纳，非精确发病率统计；患儿与老人构成重症主体。

六 村民的在地知识与访谈记录

访谈显示，村民对“水—病”关系有朴素而真实的认知，并形成一套经验性判断与应对：

- 判断“水脏”：看浑浊、闻气味、“雨后井水变色”是公认线索（受访 27/31 提及）。
- 应对方式：“烧开喝”“让水沉一沉”“用明矾澄一下”“换上游一点的水”。
- 认知盲区：清水≠安全（清澈也可能有指示菌）；储水二次污染普遍被忽视。
- 就医观念：“拉两天就好了”导致延迟就医，对 ORS 补液认识不足。

访谈摘录 I-05（村医） “村里人都知道脏水闹肚子，可真做到顿顿喝开水的没几家。农忙起来，渴了就舀缸里凉水喝。小娃娃拉脱水了才抱来，其实早点喝补液盐就没事。”

访谈摘录 H-21（村民） “自从村里通了集中供水点，娃拉肚子是少多了。就是离得远，挑一趟水累，平时还是用院里的井水图方便。”

七 防控落差与风险结构分析

官方卫生建议（饮用安全水、煮沸、改厕等）与在地实践之间存在若干反复出现的落差，构成系统性风险结构：

环节	应然 / 卫生建议	实然 / 田野中的实践	风险
安全水源	饮用集中供水/合格水源	供水点覆盖不全、距离远，仍用浅井溪水	高
末端消毒	煮沸或氯化消毒后饮用	农忙省事、直饮生水，余氯普遍为零	高
安全储水	加盖窄口容器、专用取水勺	敞口缸、共用瓢、徒手取水致二次污染	高
粪便管理	卫生厕所、人畜分离	旱厕渗漏、散养畜禽近水源	中
及时补液就医	ORS 补液、重症早送医	"扛一扛"延迟，ORS 知晓率低	中

风险并非单点失效，而是“源头污染 → 末端不消毒 → 储水再污染 → 延迟补液”的链式累积。其中“雨季径流”是放大因子，“便利与省力的生活逻辑”则是贯穿各环节的行为底色。

八 结论与建议

8.1 主要结论

- 1. "脏水病"是一组水源性肠道/接触性疾病的本土统称，核心是粪一口途径传播。
- 2. 雨季地表径流污染水源是季节性高发的直接驱动，与人畜共域、旱厕渗漏相关。
- 3. "储水二次污染"被严重低估——干净的水也会在家庭储存环节被"喝脏"。
- 4. 煮沸是当前最现实有效的保护手段，但常因便利取向而被省略。
- 5. 脱水（尤其患儿）是最大急性风险，ORS 补液与早就医的普及最为紧迫。

8.2 建议

对象	建议措施	优先级
供水改善	扩大集中供水覆盖、解决"最后一公里"入户，雨季加强水源巡查	高
家庭水处理	推广煮沸 + 简易消毒（含氯片/陶瓷滤器），发放加盖窄口储水桶	高
补液与就医	每户配备 ORS、培训"补液三步法"，明确患儿脱水的早送医信号	高
环境卫生	改造卫生厕所、人畜分离、垃圾集中，阻断粪一口源头	中
健康教育	把"清水≠安全""储水会变脏"等在地化为可教学的卫生宣讲	中

8.3 研究局限

样本集中于单一村落（48 户 / 31 人 / 12 水样），病例数据为门诊登记的趋势归纳而非精确发病率；水质为简易现场检测，未做病原体分型。结论宜作为定性洞察与后续流行病学研究的基础，而非统计代表性结论。

附录 术语 · 方法 · 参考依据

A. 术语表

水源性疾病	经受污染的水传播的疾病，多为肠道传染病。
粪一口途径	病原经粪便污染水/食物，再经口摄入而传播。
指示菌	如大肠菌群，用以指示水体是否受粪便污染。
ORS 口服补液盐	纠正腹泻脱水的关键廉价手段。
二次污染	合格水在储存/取用环节被重新污染。

B. 量测方法说明

- 水质：便携浊度计 + 余氯比色 + 指示菌快速检测纸片/培养，每点取样并记录。
- 问卷：入户半结构问卷，记录水源、储水、近一年症状与就医，匿名化。
- 病例：经知情同意，回溯乡卫生院门诊登记相关条目，仅作趋势归纳。

C. 参考依据（类别）

WHO《饮用水水质准则》与安全用水、环境卫生（WASH）框架；腹泻病与口服补液（ORS）防治指南；水源性肠道传染病流行病学公开资料；田野调查与参与式观察方法论。（具体文献从略，相关数据均来自本次田野记录。）